## Penyusunan Rekomendasi

**Dalam bagian ini, setelah melakukan evaluasi desain kurikulum, kita akan berlatih merancang ulang rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut dengan menyusun rekomendasi perubahan.**

**LEMBAR KERJA K 5.3 REKOMENDASI PERBAIKAN**

**Tujuan: Peserta PPG dapat merancang ulang rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi desain kurikulum menggunakan pendekatan UbD.**

**Alur : Rujuklah butir-butir pada LK 2 secara spesifik untuk membuat rekomendasi per tahap di LK 3. Isilah Lk 3 dengan petunjuk berikut**

**Isi kolom LK-3:**

- **Tahap (1/2/3) yang ditarget.**
- **Uraian rekomendasi (spesifik & realistis).**
- **Rasional (rujuk temuan LK-2)**
- **Prasyarat/dukungan (alat, waktu, koordinasi).**

**Identitas Kelompok: 1**

| *No* | *Nama* | *Nim* |
|---|---|---|
| *1.* | **Maruf Hamen** | **2025492661** |
| *2.* | **Wa Mirna** | **2025492664** |
| *3.* | **Bella Carlin Ririhatuela** | **2025492670** |
| *4.* | **Munir Rotu Rohmah** | **2025492677** |

**Kelas: Ilmu Pendidikan**

**Tanggal: 3 Juni 2026**

**Petunjuk Singkat:**

**Susun rekomendasi berdasarkan temuan LK-2. Setiap butir menyebut tahap, uraian rekomendasi, rasional (rujuk LK-2), dan prasyarat/dukungan yang dibutuhkan**

**Keterangan Kode Bukti LK-2**

| Kode Bukti | Inti Temuan LK-2 yang Dirujuk |
|---|---|
| LK-2.T1 | Temuan tahap 1: tujuan pembelajaran sudah memuat konsep, pola hidup, dan komunikasi, tetapi pertanyaan esensial belum ditulis eksplisit dan indikator lebih tampak pada kisi-kisi tes. |
| LK-2.T2 | Temuan tahap 2: asesmen berupa tes tertulis dan poster; tes dominan C1-C2, sedangkan kriteria poster menilai kerapian, label, dan estetika visual. Bukti untuk tujuan pola hidup belum kuat. |

| | |
|---|---|
| LK-2.T3 | Temuan tahap 3: kegiatan belajar berupa membaca handout, mengamati diagram, tanya jawab, diskusi, poster, presentasi, dan tes; aktivitas analisis pola hidup belum dijabarkan rinci. |
| LK-2.C2 | Keselarasan lintas-tahap pada tujuan "mengenali kaitan pola hidup dengan kesehatan peredaran darah" masih terbatas karena bukti dan aktivitas khusus belum eksplisit. |
| LK-2.C3 | Keselarasan tujuan komunikasi sudah ada melalui poster dan presentasi, tetapi kualitas komunikasi lisan dan tanggung jawab penyampaian informasi belum menjadi kriteria penilaian. |

## A. Tujuan Perbaikan (1 paragraf)

Rancangan ulang diarahkan untuk memperkuat keselarasan antar-tahap UbD pada unit "Sistem Peredaran Darah Manusia". Perbaikan difokuskan pada tiga hal, yaitu memperjelas hasil yang diinginkan dengan menambahkan pertanyaan esensial dan indikator transfer yang menghubungkan konsep sistem peredaran darah dengan pola hidup sehat remaja; memperbaiki bukti penilaian agar tidak hanya menilai hafalan dan tampilan poster, tetapi juga menilai pemahaman sebab-akibat kebiasaan harian terhadap kesehatan peredaran darah, komunikasi lisan, dan refleksi diri; serta menata kegiatan belajar agar murid membaca kasus, menganalisis artikel/diagram, berdiskusi, membuat rekomendasi pola hidup sehat, merevisi produk, mempresentasikan hasil, dan melakukan refleksi. Perbaikan ini tetap realistis karena dapat dilakukan di ruang kelas dengan sumber yang sudah tersedia, seperti buku teks, handout, artikel populer kesehatan remaja, proyektor, papan tulis, kertas plano/flipchart, dan alat tulis/warna, tanpa menambah kebutuhan laboratorium.

## B. Rekomendasi Per tahap

| Tahap | Uraian Rekomendasi (spesifik) | Rasional (rujuk temuan LK-2) | Prasyarat/Dukungan |
|---|---|---|---|
| 1 | Perjelas hasil yang diinginkan dengan menambahkan Big Idea, pertanyaan esensial, dan indikator transfer. Big Idea: sistem peredaran darah bekerja menjaga tubuh tetap hidup, sehingga kebiasaan sehari-hari perlu dipilih secara bertanggung jawab. Pertanyaan esensial: (1) Mengapa kebiasaan sehari-hari dapat memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah? (2) Bagaimana pengetahuan tentang sistem peredaran darah membantu remaja mengambil keputusan hidup sehat? Indikator transfer: murid mampu menganalisis satu kasus kebiasaan remaja, menjelaskan dampaknya terhadap sistem peredaran darah, dan menyusun minimal dua saran pola hidup sehat berbasis informasi yang dipelajari. | LK-2.T1 menunjukkan bahwa tujuan sudah memuat konsep, pola hidup, dan komunikasi, tetapi pertanyaan esensial belum eksplisit. LK-2.C2 juga menunjukkan bahwa tujuan tentang hubungan pola hidup dengan kesehatan peredaran darah belum memiliki penghubung yang kuat ke bukti dan aktivitas. Karena itu, tahap 1 perlu diperjelas agar arah belajar tidak hanya menuju penguasaan istilah, tetapi juga transfer pemahaman ke kehidupan remaja. | Koordinasi singkat dengan GP untuk menyepakati tujuan revisi; menyiapkan 2-3 pertanyaan esensial di papan/proyektor; menggunakan artikel populer kesehatan remaja yang sudah tersedia dalam kasus; waktu 10 menit pada awal pertemuan untuk menjelaskan arah belajar. |
| 2 | Perbaiki asesmen dengan menambahkan bukti yang sesuai dengan tujuan pola hidup dan komunikasi. Tes tertulis tetap digunakan, tetapi ditambah dua soal berbasis kasus pada level C3-C4, misalnya menganalisis kebiasaan begadang, kurang olahraga, konsumsi makanan tinggi garam/lemak, atau stres terhadap | LK-2.T2 menunjukkan bahwa tes tertulis lebih dominan mengukur C1-C2 dan poster dinilai dari kerapian, kelengkapan label, serta estetika visual. LK-2.C3 menunjukkan bahwa komunikasi melalui poster dan presentasi sudah ada, tetapi kualitas | Kisi-kisi tes direvisi dengan 2 soal kasus; rubrik poster/presentasi dibuat sederhana; menyediakan lembar exit ticket; membutuhkan waktu tambahan sekitar 10-15 menit untuk presentasi dan refleksi; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kesehatan peredaran darah. Tugas poster diubah menjadi poster infografis "Jaga Sistem Peredaran Darah Tetap Sehat" yang memuat komponen/fungsi darah, hubungan kebiasaan remaja dengan kesehatan peredaran darah, dan minimal dua rekomendasi hidup sehat. Rubrik poster/presentasi ditambah kriteria akurasi konsep, relevansi pesan kesehatan, penggunaan sumber, kejelasan komunikasi lisan, serta tanggung jawab saat menjawab pertanyaan. Tambahkan exit ticket atau refleksi singkat tentang satu kebiasaan sehat yang akan diterapkan murid. | komunikasi belum dinilai secara khusus. Dengan memperbaiki asesmen, bukti belajar menjadi lebih selaras dengan tujuan pola hidup, pemahaman mendalam, dan komunikasi kepada teman sebaya. | sumber bacaan tetap menggunakan handout dan artikel populer yang tersedia. |
| 3 | Susun ulang alur kegiatan pembelajaran agar aktivitas menyiapkan murid mencapai bukti asesmen. Pertemuan 1 diawali asesmen awal cepat dan kasus pemantik tentang remaja yang sering begadang, jarang bergerak, atau kurang menjaga pola makan. Murid membaca handout dan artikel singkat, mengamati diagram, lalu mengisi LKPD "Kebiasaan - Dampak - Saran". Kelompok mulai membuat draf poster dengan fokus pada konsep dan pesan kesehatan. Pertemuan 2 digunakan untuk merevisi poster berdasarkan rubrik, presentasi singkat, umpan balik teman, tes tertulis, dan exit ticket. Alur ini memuat unsur WHERETO: tujuan dan harapan jelas (W), kasus pemantik menarik perhatian (H), murid dibekali konsep dan pengalaman analisis (E), ada kesempatan merevisi poster (R), murid mengevaluasi diri melalui exit ticket (E), tugas dapat disesuaikan dengan minat/kemampuan kelompok (T), dan kegiatan diatur bertahap dari kasus sampai refleksi (O). | LK-2.T3 menunjukkan aktivitas sudah meliputi membaca, mengamati, tanya jawab, diskusi, poster, presentasi, dan tes. Namun, LK-2.C2 menunjukkan kegiatan khusus untuk menganalisis hubungan pola hidup dengan kesehatan peredaran darah belum rinci. Rekomendasi tahap 3 diperlukan agar aktivitas tidak hanya mendukung penguasaan komponen darah, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan transfer dan asesmen yang diperbaiki pada tahap 2. | Menyiapkan kartu kasus, LKPD analisis, timer presentasi, rubrik poster/presentasi, dan lembar umpan balik teman; mengatur kelas untuk kerja kelompok kecil; tidak memerlukan laboratorium karena seluruh aktivitas dapat dilakukan dengan bahan bacaan, diagram, proyektor, dan kertas plano/flipchart. |

## C. Perbaikan Berdasarkan Rekomendasi

Berikut rancangan ulang rencana pembelajaran berdasarkan rekomendasi pada bagian A dan B. Rancangan ini menindaklanjuti kode bukti LK-2.T1, LK-2.T2, LK-2.T3, LK-2.C2, dan LK-2.C3.

### 1. Tahap 1 – Hasil yang diinginkan

| Komponen | Rancangan Ulang |
|---|---|
| Big Idea | Sistem peredaran darah menjaga tubuh tetap hidup melalui kerja darah, jantung, dan pembuluh darah. Kesehatan sistem ini dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, sehingga remaja perlu membuat pilihan hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab. |
| Tujuan Pembelajaran | Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, murid mampu menjelaskan konsep dasar sistem peredaran darah, menganalisis hubungan kebiasaan/pola hidup dengan kesehatan sistem peredaran darah, serta mengomunikasikan pesan kesehatan berbasis informasi yang dipelajari kepada teman sebaya melalui poster dan presentasi singkat. |

| | |
|---|---|
| Pertanyaan Esensial | 1) Mengapa kebiasaan sehari-hari dapat memengaruhi kesehatan sistem peredaran darah?<br>2) Bagaimana pengetahuan tentang sistem peredaran darah membantu remaja mengambil keputusan hidup sehat?<br>3) Informasi seperti apa yang perlu disampaikan agar teman sebaya lebih peduli menjaga kesehatan peredaran darah? |
| Indikator Ketercapaian | Murid mampu: (1) menjelaskan komponen darah, alur peredaran darah, dan perbedaan arteri-vena; (2) menganalisis minimal satu kasus kebiasaan remaja dan dampaknya terhadap kesehatan peredaran darah; (3) menyusun minimal dua rekomendasi pola hidup sehat; (4) menyampaikan informasi pokok secara jelas, akurat, dan bertanggung jawab kepada teman sebaya. |

## 2. Tahap 2 – Bukti/Asesmen

| Bentuk Bukti | Rancangan Ulang | Kriteria/Ketentuan |
|---|---|---|
| Tugas kinerja | Poster infografis dan presentasi singkat "Jaga Sistem Peredaran Darah Tetap Sehat". Produk memuat komponen/fungsi darah, hubungan kebiasaan remaja dengan kesehatan peredaran darah, dan rekomendasi tindakan sehat. | Akurasi konsep; keterkaitan konsep dengan pola hidup; kejelasan pesan kesehatan; kelengkapan informasi; kerapian/visual; penggunaan sumber; kejelasan komunikasi lisan; kemampuan menjawab pertanyaan. |
| Tes tertulis | Pilihan ganda dan esai singkat tetap digunakan untuk mengukur konsep dasar. Ditambahkan dua soal kasus yang meminta murid menganalisis dampak kebiasaan tertentu terhadap kesehatan sistem peredaran darah. | Soal mencakup C1-C2 untuk konsep dasar dan C3-C4 untuk penerapan/analisis kasus; jawaban esai dinilai dari ketepatan konsep, alasan, dan saran yang logis. |
| Bukti formatif | Asesmen awal cepat, LKPD "Kebiasaan - Dampak - Saran", tanya jawab, catatan diskusi, draf poster, umpan balik teman, dan exit ticket/refleksi diri. | Murid menunjukkan keterlibatan, mampu menghubungkan informasi bacaan dengan kasus, memperbaiki draf berdasarkan masukan, dan menuliskan satu tindakan sehat yang akan diterapkan. |

## 3. Tahap 3 - Rencana Pembelajaran

| Pertemuan | Alur Kegiatan Rancang Ulang | Keterkaitan UbD/WHERETO |
|---|---|---|
| Pertemuan 1<br>2 x 40 menit | Pendahuluan: guru membuka pembelajaran, melakukan apersepsi, dan menampilkan kasus singkat tentang remaja yang sering begadang, kurang bergerak, atau sering mengonsumsi makanan kurang sehat. Guru mengajukan asesmen awal cepat melalui pertanyaan: "Apa yang mungkin terjadi pada tubuh jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus?"<br>Inti: murid membaca handout dan artikel singkat kesehatan remaja, mengamati diagram sistem peredaran darah, lalu berdiskusi dalam kelompok untuk mengisi LKPD "Kebiasaan - Dampak - Saran". Setelah itu kelompok mulai menyusun draf poster dengan menautkan komponen darah, cara kerja | W: tujuan dan harapan belajar dijelaskan sejak awal.<br>H: kasus remaja digunakan sebagai pemantik.<br>E: murid dibekali konsep melalui handout, artikel, dan diagram.<br>T: kelompok dapat memilih kebiasaan yang paling dekat dengan kehidupan mereka untuk dianalisis. |

| | | |
|---|---|---|
| | peredaran darah, dan pesan hidup sehat.<br>Penutup: guru bersama murid menyimpulkan konsep utama dan meminta tiap kelompok menandai bagian poster yang masih perlu diperbaiki. | |
| Pertemuan 2<br>2 x 40 menit | Pendahuluan: guru mengulas kembali hasil diskusi dan menampilkan rubrik poster/presentasi.<br>Inti: murid merevisi poster berdasarkan rubrik, menambahkan rekomendasi pola hidup sehat, lalu melakukan presentasi singkat. Kelompok lain memberi satu apresiasi dan satu saran melalui lembar umpan balik. Setelah presentasi, murid mengerjakan tes tertulis yang mencakup konsep dasar dan dua soal kasus.<br>Penutup: guru memberi umpan balik umum, menguatkan hubungan sistem peredaran darah dengan kebiasaan sehat, dan meminta murid mengisi exit ticket: "Satu kebiasaan yang akan saya perbaiki untuk menjaga kesehatan peredaran darah adalah..." | R: murid merevisi poster sebelum presentasi.<br>E: murid mengevaluasi pemahaman melalui tes dan exit ticket.<br>O: kegiatan disusun bertahap dari pemahaman konsep, analisis kasus, produksi poster, presentasi, sampai refleksi.<br>Kegiatan tetap realistis karena dilakukan di ruang kelas tanpa laboratorium. |

Catatan Koherensi **A→B→C**

Bagian A menetapkan arah perbaikan secara umum, bagian B merinci rekomendasi pada tahap 1, 2, dan 3 dengan rasional berbasis LK-2, sedangkan bagian C menindaklanjuti rekomendasi tersebut ke dalam rancangan ulang yang utuh. Dengan demikian, ketidakselarasan utama pada tujuan pola hidup, bukti asesmen, dan aktivitas pembelajaran diperbaiki melalui pertanyaan esensial, asesmen berbasis kasus, rubrik poster/presentasi yang lebih lengkap, LKPD analisis, kesempatan revisi, presentasi, serta refleksi diri murid.

**Untuk menilai tugas rekomendasi perbaikan rancangan pembelajaran, silakan gunakan rubrik penilaian berikut ini.**

| Kriteria | Tidak tampak (0) | Terlihat, namun lemah (1) | Cukup jelas (2) | Sangat jelas dan konsisten (3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Spesifik & realistis terhadap konteks | Pernyataan umum, tidak jelas apa yang diperbaiki | Arah perbaikan ada tetapi samar; konteks & keterbatasan tidak dipertimbangkan | Fokus perbaikan jelas; ruang lingkup dan keterbatasan utama disebut | Ruang lingkup rinci terukur seperlunya; langkah inti logis; selaras sumber daya dan kendala riil |
| 2. Rasional berbasis LK-2 (wajib sebut kode bukti) | Tidak merujuk pada LK-2 | Menyebut LK-2 secara umum, tanpa menyertakan bukti | Merujuk butir LK-2 dengan menyertakan bukti | Diagnosis hal-hal yang harus diperbaiki disajikan dengan ringkas dan tepat; merujuk butir, bukti, dan inti temuan LK-2 |
| 3. Ketepatan tahap UbD (1/2/3) | Tahap tidak disebut | Tahap disebut tetapi kurang tepat | Tahap sesuai dengan hal-hal yang harus diperbaiki | Tahap sangat tepat dan menjembatani kebutuhan antar-tahap secara logis |
| 4. Koherensi ke rancang ulang (A→B→C) | Tidak ditindaklanjuti di bagian C | Hanya ditindaklanjuti sebagian kecil di bagian C | Mayoritas rekomendasi tercermin di C | Semua rekomendasi terintegrasi di C; ketidakselarasan diperbaiki dengan jelas |